

FÁRMACOS EN LA LACTANCIA

Irene Ramiro

La exposición a fármacos durante el embarazo y la lactancia es muy frecuente. Los fármacos comúnmente más utilizados son: vitaminas, sales minerales, sales de hierro, ácido fólico, antiácidos, y antieméticos.

Se sabe poco de los efectos que ejercen los fármacos en la lactancia. Hay que considerar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio, y cuando se decide tratar hay que disminuir al mínimo la exposición al lactante con recomendaciones tales como evitar fármacos de acción prolongada, así como dar la dosis en la tetada o inmediatamente después. No deberíamos retirar la lactancia antes de asegurarnos que esta medida es totalmente imprescindible. Que un medicamento se excrete en leche materna no implica necesariamente toxicidad para el lactante, ya que en la mayoría de los casos los niveles plasmáticos alcanzados son de escasa relevancia clínica.

La mayoría de medicamentos que se pueden administrar a dosis terapéuticas a recién nacidos y lactantes pequeños no le causarán gran problema por recibirlos a dosis subterapéuticas a través de la leche de su madre.

Entre Los Fármacos Compatibles Con La Lactancia Destacamos.

- **Analgésicos:** se prefiere paracetamol y resto de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (salvo sulindac) a AAS y resto de salicilatos. En cuanto a narcóticos se pueden usar codeína, morfina, meperidina (si bien ésta produce cierta sedación a alta dosis).
- **Anticoagulantes:** icumarol, warfarina, heparina, enoxaparina.
- **Antihistamínicos:** astemizol, broncofeniramina, clorfeniramina, dexbromfeniramina, difenhidramina, mefodilazina.
- **Antiinfecciosos:** penicilinas, cefalosporinas, clindamicina, eritromicina, tetraciclinas tópicas, aztreonam, moxalactam, antifúngicos (nistatina, clotrimazol), aminoglucósidos (gentamicina, estreptomicina, kanamicina), antisépticos urinarios (ácido nalidíxico, nitrofurantoína) y otros tales como cotrimazol, trimetropim.
- **Aparato digestivo:** cimetidina, loperamida, sucralfato.
- **Aparato respiratorio:** teofilina, aminofilina, difilina, yoduro potásico.
- **Hormonas:** corticoides (prednisona, prednisolona), antitiroideos (propiltiouracilo, metimazol, carbimazol), tiroides (levotiroxina), antidiabéticos (insulina, tolbutamida) y contraceptivos orales.
- **Diuréticos:** acetazolamida, clortalidona, furosemida, hidroclorotiacida, torasemida, espironolactona.
- **Sistema cardiovascular:** digoxina, diltiazem, isopiramide, hidralacina, labetalol, lidocaína, captopril, enalapril.
- **Antigotosos:** alopurinol, colchicina.
- **Sistema nervioso (SN) autónomo:** atropina, baclofeno, escopolamina, metocarbamol, piridostigmina, pseudoefedrina, terbutalina.
- **Sistema nervioso central:** valproico, carbamacepina, domipramina, etosuximida, fenitoína, secobarbital, sulfato de magnesio

Clasificación de seguridad en la utilización de fármacos según la Food and Drug Administration.

- **A.** No han demostrado riesgo para el feto en estudios controlados en mujeres en el primer trimestre, la posibilidad de daño fetal es remota.
- **B.** No han demostrado riesgo para el feto en estudios en animales pero no hay estudios controlados en mujeres. Podrían ser útiles en mujeres a pesar de su riesgo potencial.

- **C.** Estudios controlados en animales han demostrado efectos adversos sobre el feto, no hay estudios controlados en mujeres.
- **D.** Evidencia de riesgo fetal, pero los beneficios para las gestantes pueden ser aceptables a pesar del riesgo, en caso de amenaza para la vida.
- **E.** El riesgo de utilizar el medicamento en embarazadas supera cualquier posible beneficio.

Niveles de riesgo de fármacos en la lactancia

- Nivel 0: seguridad demostrada para la lactancia y el lactante.
- Nivel 1: producto moderadamente seguro, efectos adversos muy leves sobre la lactancia o el lactante.
- Nivel 2: producto poco seguro, valorar relación riesgo beneficio. De no ser posible evitar su uso, se debe de considerar la dosis, la edad del lactante y realizar seguimiento.
- Nivel 3: No recomendado, producto contraindicado.

Tabla I. Fármacos contraindicados en la lactancia
Anticoagulantes: Fenindiona
Cardiovasculares: Amiodarona (por el Yodo), Derivados del Ergot (inhiben prolactina): Ergotamina
Ginecológicos: Derivados del ergot: Bromocriptina, Cavergolina y Lisurida
Antineoplásicos ¹
Psicofármacos: Anfetaminas
Yoduros, incluso tópicos
Drogas de abuso social:
Anfetamina, Cocaína, Fenciclidina, Heroína, LSD, Marihuana
Alcohol en exceso

Pero son compatibles con la lactancia a dosis inmunomoduladoras, como las que se prescriben para enfermedades sistémicas

Tabla II. Fármacos a tomar con precaución en la lactancia
Antibióticos: Amantadina (RL), Cloranfenicol (H).
Antiepilépticos: Fenobarbital, Primidona (S),
Antihistamínicos de primera generación (S, RL)
Antiinfecciosos: quinolonas (O); clindamicina (G); Lindano (H)
Antiinflamatorios: Sales de oro (O)
Cardiovasculares: Reserpina (S)
• Betabloqueantes (CV) (menos Labetalol, Oxprenolol o Propranolol)
• Antiadrenergicos/Vasodilatadores (CV) (No Metildopa ni Hidralazina)
Descongestivos nasales (CV, I)
Diuréticos: Tiazidas (RL)
Drogas sociales: Alcohol (S), Cafeína (I), Tabaco (I)
Endocrinológicos: algunos antidiabéticos orales; estrógenos (RL)
Gastrointestinales: Laxantes "activos" (G)
Inmunosupresores (H) (de elección Ciclosporina y Azatioprina)
Psicofármacos

Tabla II. Fármacos a tomar con precaución en la lactancia

• Clorpromacina (S):
• Benzodiacepinas (S) (elegir Lorazepam como ansiolítico)
• Doxepina (S, CV) (elegir Sertralina, Paroxetina o Fluoxetina)
• Nefazodona (S, CV) (elegir Sertralina, Paroxetina o Fluoxetina)
• Antipsicóticos Fenotiazinas (S)
• Litio (CV, S): Requiere control clínico y analítico del lactante. Mayor precaución en madres con insuficiencia renal, en prematuros y en período neonatal.
Posibles efectos a observar: CV CardioVasculares, G Gastrointestinales, H Hematológicos, I Irritabilidad-
Insomnio, O Otros, RL Reducción láctea, S Sedación

LAS PLANTAS MEDICINALES Y LOS PRODUCTOS A BASE DE PLANTAS

La confusa y poco contrastada información, junto con el ambiguo marco legal de comercialización de los productos herbales, hace particularmente difícil responder a consultas en las que las infusiones están implicadas. Su consumo ha crecido espectacularmente en los últimos años. La mayoría contiene principios farmacológicamente activos y existe la dificultad añadida de falta de estandarización de su composición, multiplicidad de nombres vulgares para los mismos, posibilidad de confusión de productos diferentes y falta de buenas fuentes de información. El gran contenido en flavonoides de muchas plantas, por su potente actividad estrogénica, puede frenar la lactancia; el uso crónico o abuso de plantas con pretendidas propiedades galactogogas (alcachofa, anís, comino, cimifuga, efedra, ginseng, lino, lúpulo, regaliz, romero o zarzaparrilla) puede disminuir la producción de leche. Otras plantas contienen productos tóxicos y tomadas en cantidad o tiempo suficiente podrían dañar al lactante, cuando no a la madre: es el caso de alfalfa, amapola, anís estrellado (retirado del mercado español), anís verde, artemisa, boj, boldo, caulofilo, cornezuelo, efedra, eucalipto, fucus, hinojo, hisopo, kava (retirado del mercado español), nuez moscada o salvia.

LAS ENFERMEDADES DE MADRE Y NIÑO

Pocas enfermedades de la madre hacen aconsejable suspender la lactancia y no siempre de modo universal: SIDA, virus linfotropo humano T-I y T-II, herpes simple con lesiones en las mamas, psicosis graves, la drogadicción y ciertas neoplasias; así como el Síndrome Sheehan por motivos obvios. Entre las enfermedades del lactante, sólo la galactosemia y la intolerancia congénita a la lactosa contraindican la lactancia.

Tabla III. Enfermedades que contraindican o dificultan la lactancia

DE LA MADRE
SIDA (a valorar)
Virus linfotropo humano T-I y T-II
Herpes simple con lesiones en las mamas
Psicosis graves (a valorar con psiquiatra)

Tabla III. Enfermedades que contraindican o dificultan la lactancia

Drogadicción

Neoplasias (a valorar)

Síndrome Sheehan

DEL NIÑO

Galactosemia

Intolerancia congénita a la lactosa

CONSIDERACIONES GENERALES PARA MINIMIZAR EL RIESGO

- Si no es necesario el medicamento (situaciones clínicas autolimitadas y leves), no darlo. Precaución con el dolor: la madre lactante no tiene por qué sufrirlo.
- Seleccionar medicamentos en los que está indicado el uso pediátrico.
- Utilizar la mínima dosis eficaz durante el menor tiempo posible.
- Utilizar vía tópica o inhalatoria como alternativa a la oral o parenteral.
- Evitar medicación nueva o con poca bibliografía.
- Utilizar agentes de acción corta, evitando los de liberación sostenida.
- Ser más precavidos en prematuros y recién nacidos menores de un mes.
- Aunque casi nunca es posible (lactancia a demanda frecuente), evitar dar el pecho cuando la concentración del medicamento sea máxima: administrar el medicamento inmediatamente después de darle el pecho o antes del periodo más largo de sueño del niño.
- Retirar la lactancia momentáneamente para medicaciones peligrosas a administrar por tiempos cortos o exploraciones con radiofármacos.
Tener la precaución de indicar extracción previa de leche para poder administrarla en el ínterin.
- Interrumpir la lactancia sólo si el medicamento es demasiado tóxico para el niño y es necesario para la salud de la madre.
- Los beneficios de la lactancia materna tienen más peso que el riesgo derivado de bajos niveles de contaminantes ambientales en leche humana, en muchos casos inferiores a los de leche de vaca u otros alimentos

LÍNEAS DE CONTACTO PARA INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TERATÓGENOS DE FÁRMACOS

- Servicio de información telefónica sobre teratógenos españoles para médicos y profesionales sanitarios en general (SITTE): 91 822 24 35 (lunes a viernes de 9 a 15h). Depende del Instituto de Investigación de enfermedades raras (Instituto de Salud Carlos III)
- Servicio de información telefónica para la embarazada (SITE); dirigido a la población general: 91 822 24 36 (mismos días y horario)
- Página web e-lactancia (específica para compatibilidad de fármacos y lactancia materna)

BIBLIOGRAFÍA

- Fármacos y lactancia materna 6. A. Gómez Papí^{1,3}, J. Paricio Talayero^{2,3} y R. Closa Monasterolo¹. Servicio de Pediatría. Hospital Universitari de Tarragona “Joan XXIII”. Hospital Amigo de los Niños OMS/UNICEF 1997. Facultad de medicina. Universidad Rovira i Virgili. Tarragona. 2Servicio de Pediatría. Hospital Marina Alta, Hospital Amigo de los Niños OMS/UNICEF 1998. Denia (Alicante, España). 3Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. Protocolos actualizados al año 2008.
- PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS EN EMBARAZO Y LACTANCIA M.A. García Mutiloa, S.S. Lapeña Calavia , R. Ceres Ruiz y S. Aguirre Gorospe Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Virgen del Camino. Pamplona.
- Capítulo 192. Farmacología de urgencias en el embarazo y la lactancia. A.M. García Vázquez; L. García Martínez; M. Altamirano Cifuentes; L. Antón Aguilar; F.J. Montero Pérez y L. Jiménez Murillo. Medicina de Urgencias y emergencias. 6ª edición